



M65:Profil bactériologique des bactériémies dans le service de réanimation des brûlés au CHU de Constantine

AIBECHE MEA , BECHIR L , TAMRABT A , RIGHI I , BENKHEMISSA M , KAOUACHE O , SEMRA Z , BENLABED K , BENTCHOUALA CH

1. Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, Université Salah Bounider Constantine 3
2. Laboratoire de Microbiologie, CHU Ibn Badis de Constantine, en collaboration avec le service de réanimation des brûlés

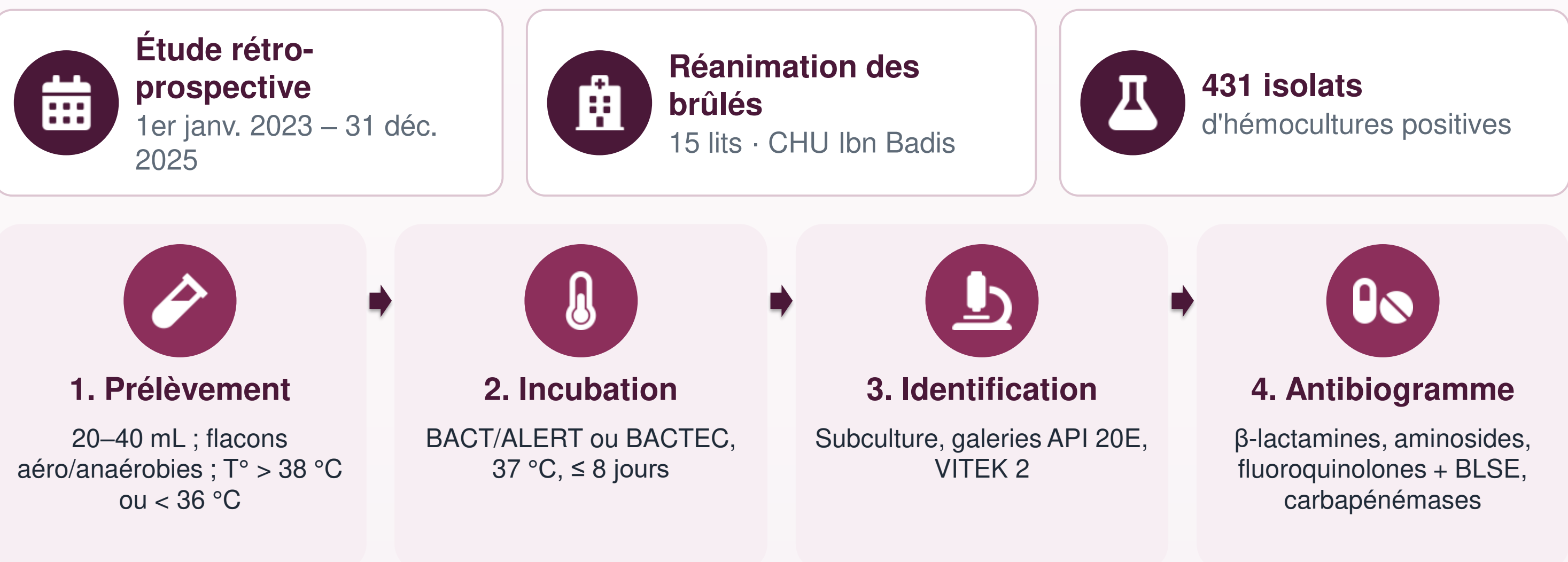
Introduction

La brûlure détruit la peau, **première barrière physique et immunologique** contre les micro-organismes. Chez le grand brûlé, les bactériémies nosocomiales sont une urgence diagnostique et thérapeutique : **≈ 51 % des décès** sont imputables à une infection [1,2], aggravée par l'émergence de **bactéries multirésistantes (BMR)**.

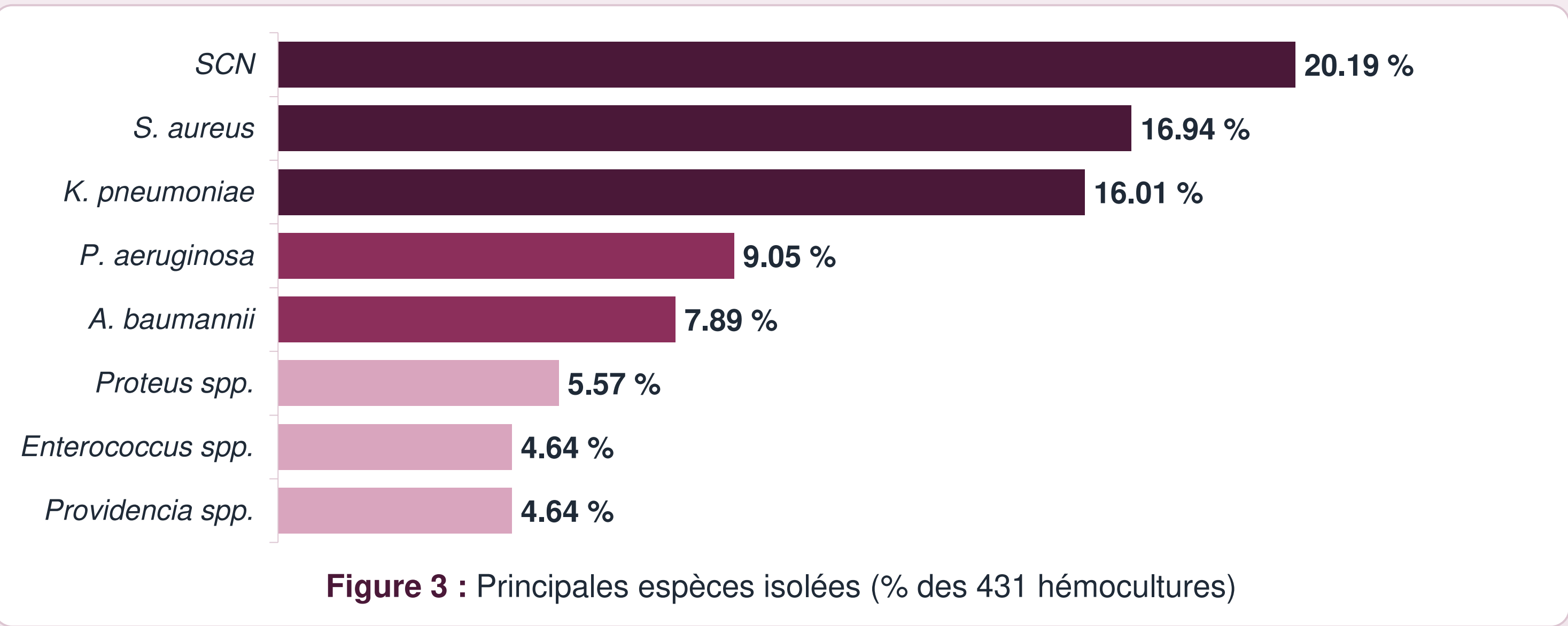
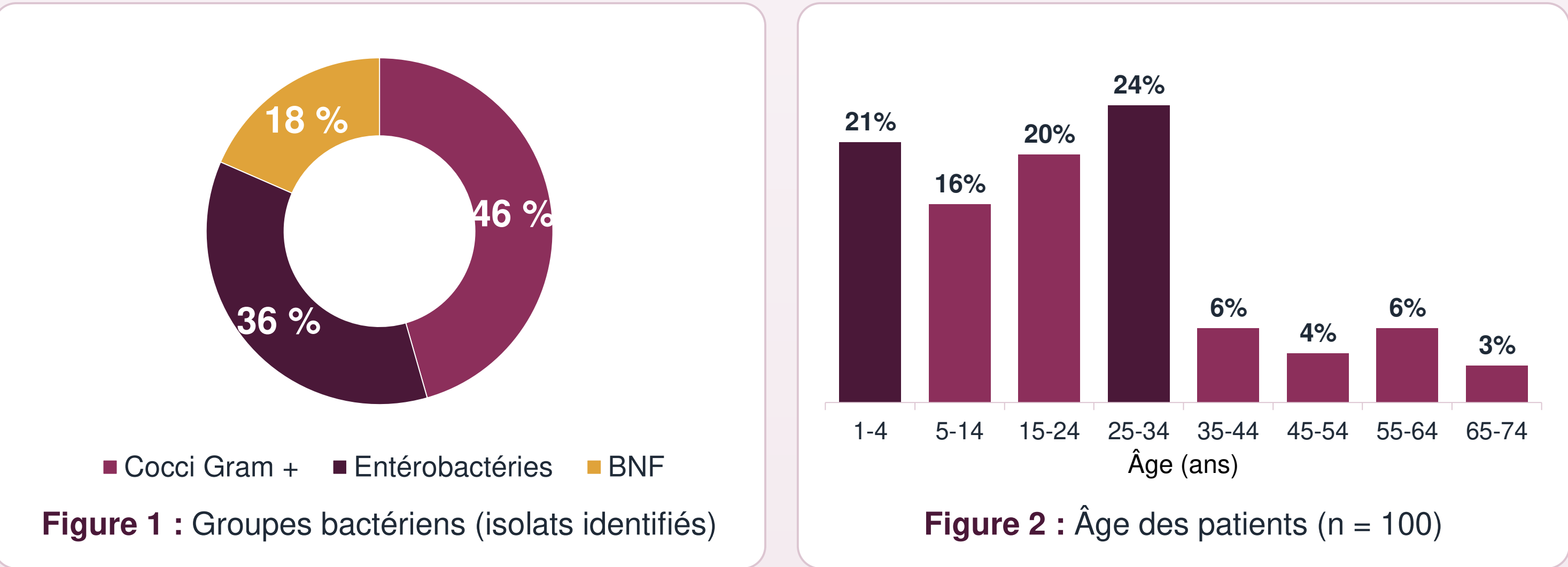
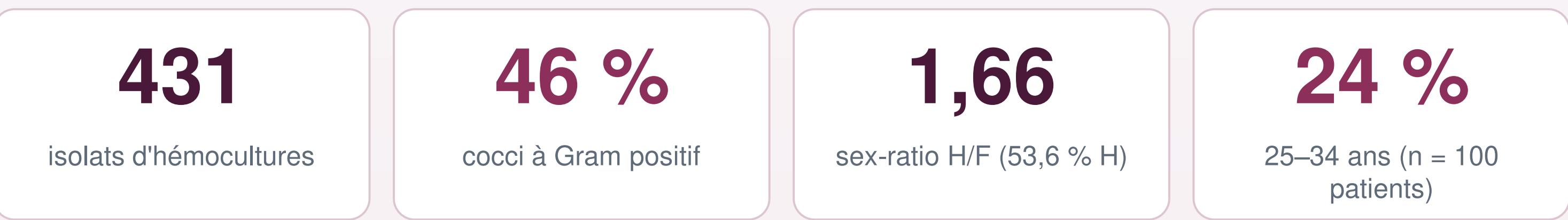
Objectifs

- **Identifier** les principales bactéries isolées des hémocultures chez les patients brûlés.
- **Déterminer** leurs profils de résistance aux antibiotiques et la fréquence des BMR.
- **Guider** l'antibiothérapie probabiliste du service.

Matériel et méthodes



Résultats



Discussion

Répartition des germes. La prédominance des cocci à Gram positif (46 %) concorde avec l'étude du centre des brûlés d'Annaba (60 %) [3], probablement en lien avec des conditions de prise en charge comparables. À l'inverse, au Centre de Traumatologie et des Grands Brûlés de Tunisie, les bacilles à Gram négatif prédominent (70,8 %) [4], différence attribuable à la durée d'hospitalisation et à l'antibiothérapie prolongée à large spectre.

Place des SCN. Les SCN occupent la première place (20,19 %), alors que les données nationales de l'AARN placent *S. aureus* en tête des hémocultures (20,81 %) [5]. Cette différence reflète notre population exclusivement brûlée : l'altération de la barrière cutanée et les dispositifs invasifs favorisent ces germes.

Staphylocoques. La résistance des SCN à la méticilline (92,75 %) rejoint celle d'une étude antérieure menée au service des brûlés du CHU de Constantine, qui retrouvait 100 % de résistance à l'oxacilline et à la céfoxitine [6].

Acinetobacter baumannii. Les résistances dépassent 90 % pour la ceftazidime, l'imipénème et la gentamicine, des taux proches de ceux observés en Tunisie (imipénème 90 %, gentamicine 92 %) [4].

Bactéries multirésistantes. En 2023, le taux d'ABRI (87,5 %) est comparable à celui de l'AARN (84,32 %), mais celui des ERV est plus de deux fois supérieur (50 % contre 22,48 %) [5], ce qui pourrait être lié à l'usage excessif des antibiotiques à large spectre et à la transmission nosocomiale.

Résistance des bacilles à Gram négatif

Antibiotique	<i>A. baumannii</i> (n = 34)	<i>K. pneumoniae</i> (n = 69)	<i>P. aeruginosa</i> (n = 39)	<i>E. coli</i> (n = 19)
Amoxicilline / Ac. clav.	—	85,48 %	—	70,59 %
Céfotaxime	—	89,47 %	—	47,06 %
Ceftazidime	96,88 %	—	21,05 %	—
Céfépime	96,30 %	86,36 %	20,69 %	30,00 %
Aztréonam	96,30 %	80,77 %	18,42 %	—
Pipéracilline / Tazobactam	92,86 %	—	35,48 %	—
Imipénème	94,12 %	73,13 %	39,47 %	—
Ertapénèm	—	72,46 %	—	—
Gentamicine	91,18 %	83,82 %	76,32 %	26,32 %
Amikacine	75,00 %	74,24 %	67,57 %	33,33 %
Ciprofloxacine	82,35 %	80,70 %	44,44 %	64,71 %
Triméthoprim / Sulfaméthoxazole	93,33 %	92,59 %	—	71,43 %

≥ 90 %

75–89 %

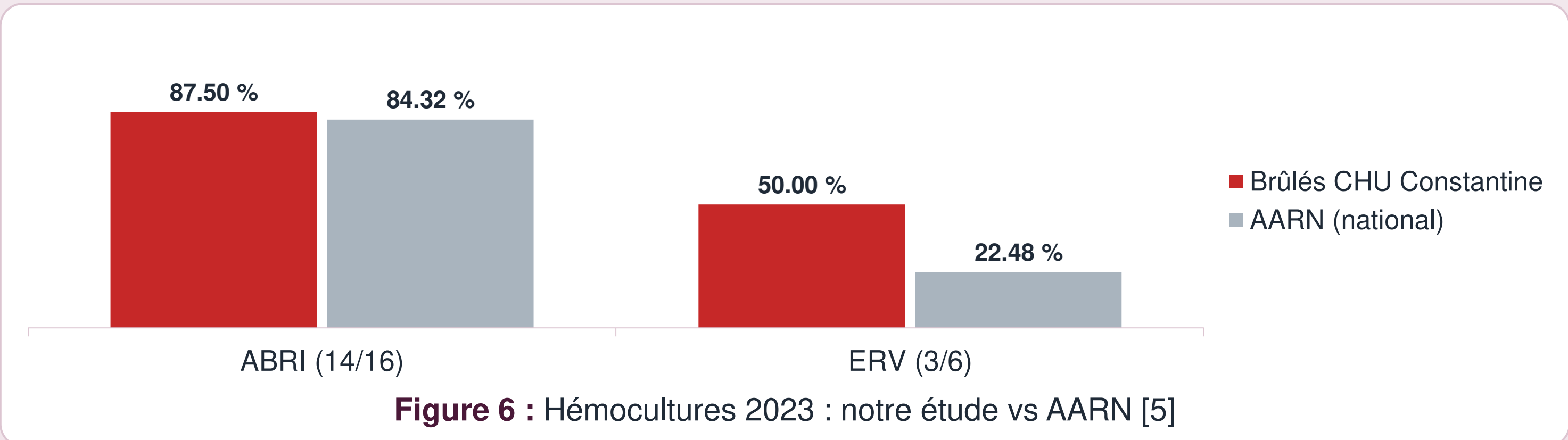
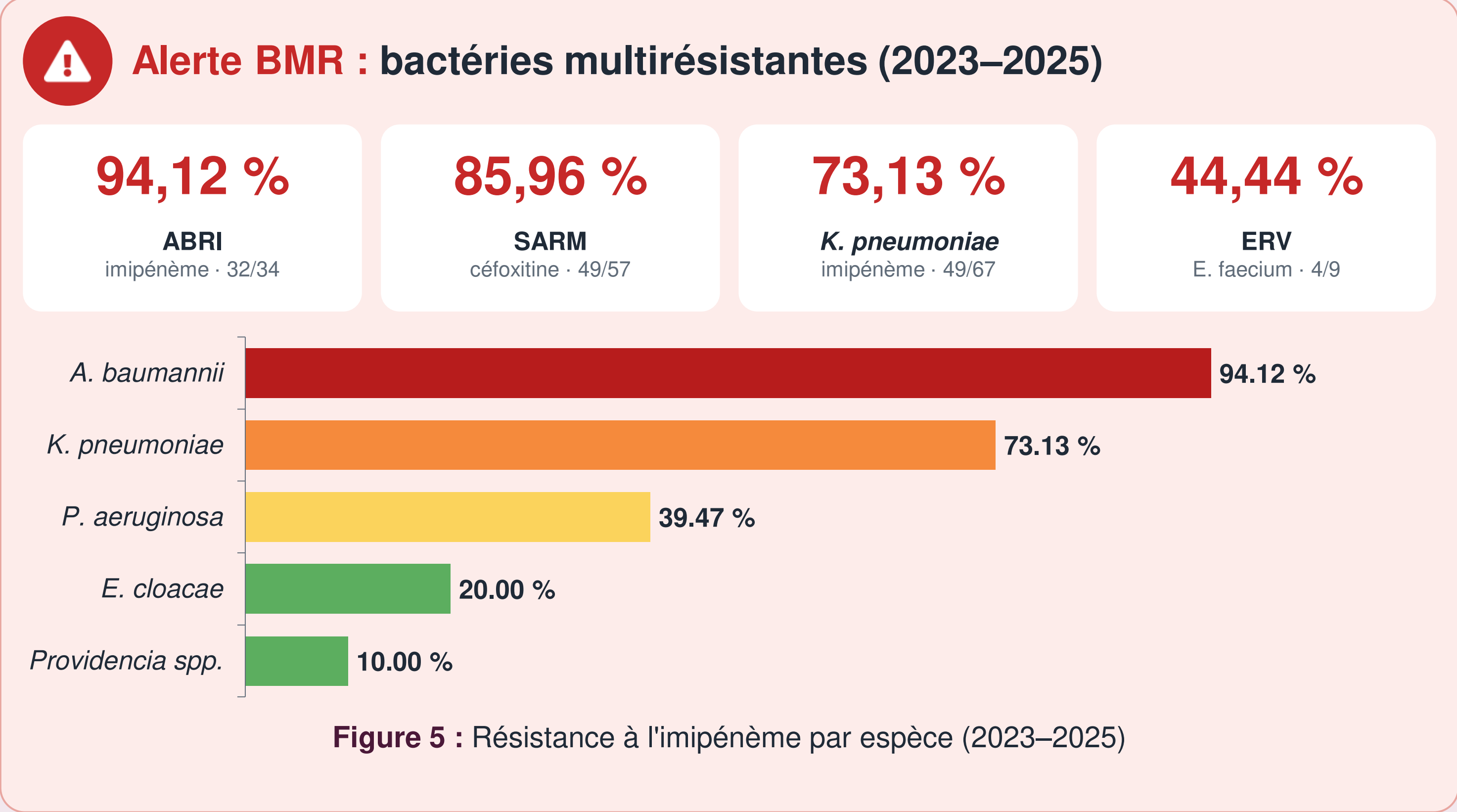
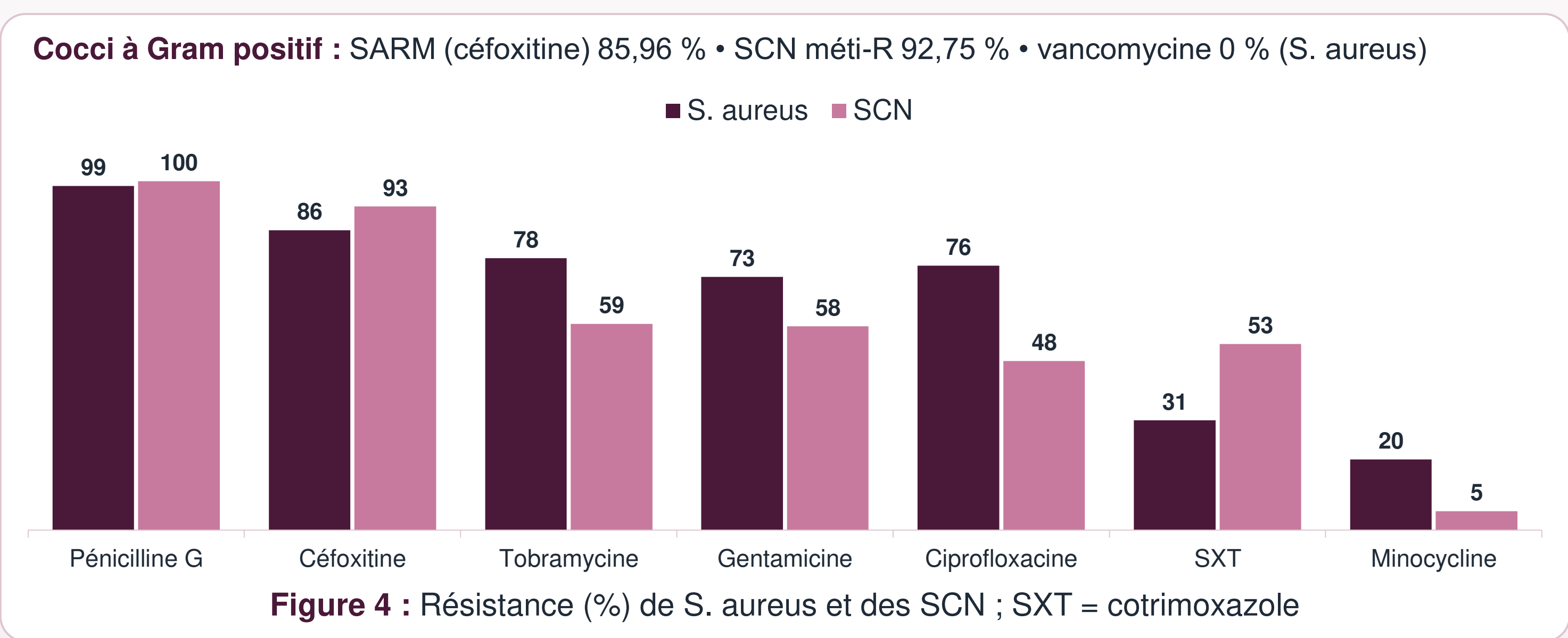
50–74 %

25–49 %

< 25 %

— non testé

Tableau 1 : Résistance (%) = souches R / souches testées. Colistine : aucune résistance chez *A. baumannii*.



Conclusion et recommandations

Écologie dominée par les **SCN, *S. aureus* et *K. pneumoniae***, avec des taux de résistance **alarmants** (ABRI 94,12 %, SARM 85,96 %).

Hygiène stricte
Mains, aseptie, dispositifs invasifs

Isolement
des patients porteurs de BMR

Bon usage des ATB
et surveillance épidémiologique